•专家共识•

北京市朝阳区老年人疫苗接种前禁忌证筛查专家共识(2024年版)

《老年接种筛查与监测管控》专家共识编写组

中国分类号：R186 **文献标识码**：A DOI：10.16440/J.CNKI.1674-8166.2025.04.07

全球老龄化负担严重，在发展中国家中尤为突出[1]。中国国家统计局对于人口老龄化的定义为：一般把60岁及以上人口占总人口比重达到10%或65岁及以上人口占总人口比重达到7%作为一个国家或地区进入老龄化社会（或老年型人口）的标准、达到14%为深度老龄化标准[2]。2020年全球60岁以上人口数量已经超过5岁以下儿童的人口数量，到2050年，全球65岁及以上人口将是5岁以下儿童人口的2倍。人口老龄化从发达国家向中低收入国家转变：预计2050年时，80%的老年人将来自中低收入国家[3]。中国在2000年已进入老龄化社会，人口老龄化处于快速深化期，积极应对人口老龄化十分关键。中国老龄化具有4大特点，规模大：中国是世界上老年人口数量最多的国家，2019年已达1.76亿人；速度快：从老龄化（7%）到深度老龄化（14%），英法两国分别用了46年和126年，中国只用了21年；发展不平衡：老龄化程度最高，辽宁省（20%）在老龄化程度中是“最年轻”的省份，是西藏自治区（5.9%）的近4倍，同时北京等一线城市老龄化的规模大、速度快[4]。由于老年人普遍机体抵抗力弱、慢性病发病率高、重症率高、致残率高、预后差，对全人群的健康构成严重威胁，改善老年人的健康状况、提升防治水平十分必要。随着全球老龄化日益严重，老年人群体已成为传染病及感染性疾病防控的重点人群，但针对老年人群体开展的预防接种工作在近年来普遍存在较多的社会关切，接种率提升困难，究其原因是包括老年人自身、老年人子女及医务人员等对预防接种特别是疫苗安全性问题的顾虑较大，故疫苗接种前禁忌证的筛查尤为重要。

基金项目：2021年度科技创新——“新一代人工智能”重大项目（2021ZD0111000）

通信作者：李书明，E-mail: kszz_001@126.com；白云骅，E-mail: 13651367636@126.com

1 老年人疫苗接种的必要性

自然衰老导致免疫系统产生退行性变化，影响机体的保护性免疫反应，与其他合并症共同使老年人更容易遭受潜伏性或新发感染，进而导致相关疾病的发病率和死亡率上升[5]。免疫衰老是多方面的生物过程，免疫细胞的结构和功能发生变化，引起先天性免疫和适应性免疫反应的衰退。免疫功能下降使老年人针对感染性病原体的易感性增加（如肺炎球菌和流行性感冒、水痘-带状疱疹病毒等），且伴随慢性病等合并症。衰老过程伴随着与年龄相关的免疫介导性炎症或炎症衰老现象，以及其他炎症性疾病也随着年龄的增长而增加[6]。年龄作为风险因素，与多种感染性疾病的发病率和死亡率上升相关，如流行性感冒、呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus，RSV）相关感染、社区获得性肺炎（community-acquired pneumonia，CAP）、带状疱疹（herpes zoster，HZ）等[7-9]。有研究证明，≥65岁人群流行性感冒相关全因死亡率平均为122.79/100 000，为全年龄平均死亡率的近9倍（14.33/100 000）[10]。中国≥65岁人群的流行性感冒住院人均费用为2 735美元，约等于其他年龄组住院费用（1 417美元）的近2倍，且老年人和儿童占流行性感冒相关住院经济负担的70%以上[11]。据统计，发展中国家≥65岁人群RSV住院病死率可达9.1%，人均治疗费用高达8 241美元[12]。考虑到RSV感染症状与其他呼吸系统疾病类似、难以鉴别诊断，且目前使用2种以上方法联合诊断可使RSV检出率翻倍，提示现在常规的单一模式极有可能导致RSV被漏诊，说明现阶段RSV导致的疾病负担极有可能被低估[13]。老年人因随着年龄上升而上升的CAP发病率和治疗用药上升产生的经济负担严重，同时老年人因CAP导致的住院负担同样严重[14-16]。

老年慢病人群接种疫苗很有必要。从个人健康

角度看，老年人免疫系统功能随年龄增长而出现衰退，且一些疫苗可预防或减少疾病危害的疾病种类在老年人中尤为普遍和严重。老年慢病人群需及时接种推荐的疫苗，提升机体对病原体的应对能力，提升生活质量，减轻个人、家庭、社会等诸多负担[17]。从医疗系统角度看，随着人口老龄化的日益加重，开展成人预防接种，尤其是老年慢病人群接种，能够降低疾病的发病率、重症率和死亡率，缓解医疗资源紧张，保障医疗卫生系统平稳运行，促进卫生系统可持续性运行[18]。从人群保护看，疫苗接种可以通过群体保护效应同时保护老年慢病人群自身以外的其他社会关系圈：如家人、邻居、朋友等。老年人可以在疫苗接种和疫苗推荐接种等方面发挥重要作用，共同为应对未来的传染病流行或大流行做好必要的准备[19]。

科学使用疫苗，合理地开展预防接种是控制感染性疾病、预防传染病最经济、最有效的方法，且老年人作为感染性疾病和传染病的易感人群，使用疫苗、开展预防接种具有重要意义。然而，老年人群体中普遍存在慢性疾病及其多种并发症，健康状况较一般成年人更为脆弱、复杂，因此，疫苗接种前禁忌证的筛查成为关键环节。本文针对老年人疫苗接种前的禁忌证筛查，梳理国内外相关研究，形成专家共识，旨在为一线预防接种工作提供相应参考，以期推动老年人群疫苗接种率的提升，充分发挥疫苗预防、控制疾病的作用。首先，充分考虑潜在受种者的病情，以及疫苗接种的安全性、必要性和有效性，接种前充分了解潜在受种者（必要时还应包括其子女或监护人的）的疑虑和担忧，正面解答和支持，尊重老人的意愿和选择，给予充分的解释和指导。有专业人员根据潜在受种者的情况做出科学、全面的评估后，按照相关预防接种工作规范的要求，为其进行疫苗接种服务。

2　老年人疫苗接种前禁忌证筛查原则

2.1　*普适性原则*　安全第一，科学评估（判断健康收益更大，风险低且可控），充分沟通。（1）既往接种疫苗时是否发生过严重过敏反应（如过敏性休克、喉头水肿）、既往对某种具体疫苗的成分是否过敏（如是，则应禁忌接种）。（2）是否处于急性感染性疾病的发热阶段（如是，则应暂缓接种，病愈后可以接种）。（3）严重的慢性疾病处于急性发作期或正在进行化疗的肿瘤患者等（如是，则应暂缓接种，病情稳定后或非化疗阶段且病情稳定时可接种）。

2.2　*个体化原则*　根据每一名潜在受种者老年人的健康状况、疾病史、药物过敏史等因素，进行个性化评估。（1）接种前应充分了解患者的过敏史、接种史、用药史、症状体征、治疗措施。（2）有急性症状的患者（如发烧、慢性疾病急性发作等）应延缓接种，如正在进行化疗的肿瘤患者、出现高血压危象的患者、冠心病患者心肌梗死发作、自身免疫性神经系统疾病处于进展期、癫痫患者处于发作期等）。（3）患有出血性疾病或者正在接受抗凝治疗的人群，肌内注射可能会出现注射部位出血、血肿等情况，需要明确告知受种者可能出现的风险，必要时咨询临床医师的意见。（4）有严重的心肺疾病，尤其是心功能和/或肺功能受损者，须慎重考虑是否可以接种，对于患有严重慢性病，特别是免疫系统疾病的老年人，应由专业人员（经过专门培训的临床医师）进行评估。（5）另外，在接种者本人和家人心理负担很重的情况下，需解决好心理问题后再接种疫苗。

2.3　*综合评估原则*　根据需要，可在接种前全面评估老年人的心、肝、肾、肺等重要脏器功能，以及慢性疾病的控制情况。

2.4　*动态观察原则*　根据需要，可在接种后对老年人的健康状况进行持续监测，根据病情变化调整疫苗接种策略。

3　老年人疫苗禁忌证

（1）如是否对疫苗成分过敏或既往接种疫苗时是否发生过严重过敏反应，主要是过敏性休克和喉头水肿。（2）对疫苗成分过敏：对疫苗活性成分、非活性成分、生产工艺中使用的物质过敏者，或以前接种同类疫苗时出现过敏反应者。（3）严重疫苗过敏反应：如过敏性休克、喉头水肿等。（4）患有未控制的癫痫和其他严重神经系统疾病：如横贯性脊髓炎、吉兰-巴雷综合征等。（5）处于发热、急性发病期：正在发热者，或患急性疾病，或慢性疾病的急性发作期，或未控制的严重慢性病患者。（6）其他禁忌证：根据具体疫苗品种说明书及临床研究，确定其他可能影响疫苗接种的禁忌证。（7）严格按照指南、疫苗说明书、《中华人民共和国药典》和上级的培训要求操作，科学和客观把握。（8）接种前应完成全部的健康状况询问和核查，根据知情同意书列举项目，结合受种者的病情判定接种禁忌，并给出建议接种、不建议接种或暂缓接种的建议。（9）必要时

可要求受种者携带近期就诊资料及开具药方，综合判断基础疾病的病情。(10) 开展老年人专场接种或进入养老机构开展上门接种时，建议配备一名全科医师协助接种护理人员开展病情核实和接种禁忌判断。(11) 原则上，慢性基础疾病稳定期可以接种疫苗。对于特殊情况无法判定的，转上一级部门或地区疫苗接种专家组进行判定，没有疫苗接种专家组的建议设立。(12) 但在判定禁忌证时，注意不应过度扩大禁忌证的范围，如认为年龄超过80岁且处于慢性病的稳定期，仍有顾虑；把鸡蛋过敏作为绝对禁忌证等。

4 老年人疫苗接种禁忌证筛查流程

(1) 健康咨询：了解老年人的健康状况、疾病史、药物过敏史、近期用药规律性等。(2) 体检：如有健康提示指征，可进行必要的体格检查，如血压、心率等。(3) 辅助检查：根据需要，进行血常规、尿常规、心电图、肝肾功能等检查。(4) 专业评估：由专业医师根据筛查结果，对有较特殊身体状况或较特殊疫苗接种需求的老年人进行综合评估，确定或排除疫苗接种禁忌证。(5) 通知与解释：向老年人及家属解释禁忌证筛查结果，指导疫苗接种。

5 结 语

老年人疫苗接种前禁忌证筛查是保障疫苗接种安全的重要环节。本专家共识从筛查原则、禁忌证、筛查流程等方面，为临床实践提供参考。在实际工作中，各接种单位均需结合老年人个体情况，动态调整疫苗接种策略，全面保障疫苗接种的安全性和有效性。

共识编写组组长：李书明（北京市朝阳区疾病预防控制中心办公室，北京 100021），白云骅（北京市朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京 100021）

执笔专家：陶丽丽（北京市朝阳区疾病预防控制中心慢性病防治科，北京 100021），张娇（北京市朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京 100021）

撰写专家名单（按照姓氏拼音顺序，排名不分先后）：白云骅（北京市朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京 100021）、程淑艳（北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心办公室，北京 100103）、崔树峰（首都医科大学附属北京友谊医院疾病预防控制与感染管理处，北京 101100）、董文兰（中国疾病预防控制中心慢病中心，北京 102206）、冯国双（首都医科大学附属北京儿童医院大数据中心，北京 100045）、侯亚楠（北京市朝阳区疾病预防控制中心慢性病防治科，北京 100021）、纪文艳（北京市疾病预防控制中心免疫规划所，北京 100013）、贾滨（北京市朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京 100021）、贾哲（北京市朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京 100021）、李书明（北京市朝阳区疾病预防控制中心办公室，北京 100021）、李臻（北京市朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京 100021）、刘东磊（北京市疾病预防控制中心器材科，北京 100013）、刘珏（北京大学公共卫生学院，北京 100191）、刘民（北京大学公共卫生学院，北京 100191）、卢莉（北京市疾病预防控制中心免疫规划所，北京 100013）、罗凤基（北京生物制品研究会，北京 100021）、吕敏（北京市疾病预防控制中心免疫规划所，北京 100013）、马建新（北京市朝阳区疾病预防控制中心办公室，北京 100021）、齐智（北京市朝阳区疾病预防控制中心慢性病防治科，北京 100021）、石文慧（中国疾病预防控制中心慢病和老龄健康管理处，北京 102206）、孙美萍（北京市疾病预防控制中心免疫规划所，北京 100013）、索罗丹（北京市疾病预防控制中心免疫规划所，北京 100013）、沈思佳（北京市通州区疾病预防控制中心慢性病预防控制科，北京 101100）、陶丽丽（北京市朝阳区疾病预防控制中心慢性病防治科，北京 100021）、王琳（首都医科大学附属首都儿童医学中心，北京 100020）、王颖（北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心办公室，北京 100124）、吴疆（北京市疾病预防控制中心免疫规划所，北京 100013）、张政（北京市朝阳区疾病预防控制中心业务办公室，北京 100021）、张娇（北京市朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京 100021）、赵伟（北京市垂杨柳医院院务部，北京 100022）、赵云娜（北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心办公室，北京 100018）

参考文献

[1] WHO. Ageing and health[EB/OL]. (2024-10-01) [2025-01-26]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health.

[2] 国家统计局. 人口老龄化及其衡量标准是什么[EB/OL]. (2023-01-01)[2025-01-26]. https://www.stats.gov.cn/zs/tjws/tjbz/202301/t20230101-1903949.html.

[3] WHO. Ageing[EB/OL]. (2022-10-01)[2025-01-26]. https://www.who.int/health-topics/ageing#tab=tab_1.
[4] 北京市老龄工作委员会办公室. 北京市老龄事业发展报告(2023)[EB/OL]. (2024-10-21)[2025-1-20]. https://mzj.beijing.gov.cn/attach/0/e579da4186d440e7890d97711cc87d91.pdf.
[5] Palacios-Pedrero MÁ, Osterhaus ADME, Becker T, et al. Aging and options to halt declining immunity to virus infections [J]. Front Immunol, 2021, 12:681449.
[6] Scott MM, Liang SY. Infections in older adults [J]. Emerg Med Clin North Am, 2021, 39(2):379-394.
[7] Sorci G, Faivre B. Age-dependent virulence of human pathogens [J]. PLoS Pathog, 2022, 18(9):e1010866.
[8] 中国疾病预防控制中心. 中国流感疫苗预防接种技术指南(2023-2024)[J]. 中国病毒病杂志, 2024, 14(1):1-19.
[9] Zhang Z, Liu X, Suo L, et al. The incidence of herpes zoster in China: A meta-analysis and evidence quality assessment [J]. Hum Vaccin Immunother, 2023, 19(2):2228169.
[10] Li J, Chen Y, Wang X, et al. Influenza-associated disease burden in mainland China: A systematic review and meta-analysis [J]. Sci Rep, 2021, 11(1):2886.
[11] Yang J, Jit M, Leung KS, et al. The economic burden of influenza-associated outpatient visits and hospitalizations in China: A retrospective survey [J]. Infect Dis Poverty, 2015, 4:44.
[12] Zhu AQ, Zheng YM, Qin Y, et al. [A systematic review of the economic burden of influenza in China] [J]. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi, 2019, 53(10):1043-1048.
[13] Kenmoe S, Nair H. The disease burden of respiratory syncytial virus in older adults [J]. Curr Opin Infect Dis, 2024, 37(2):129-136.
[14] Jiang N, Li R, Bao J, et al. Incidence and disease burden of community-acquired pneumonia in southeastern China: Data from integrated medical resources [J]. Hum Vaccin Immunother, 2021, 17(12):5638-5645.
[15] Olasupo O, Xiao H, Brown JD. Relative clinical and cost burden of community-acquired pneumonia hospitalizations in older adults in the united states-a cross-sectional analysis [J]. Vaccines (Basel), 2018, 6(3):59.
[16] Weycker D, Moynahan A, Silvia A, et al. Attributable cost of adult hospitalized pneumonia beyond the acute phase [J]. Pharmacoecon Open, 2021, 5(2):275-284.
[17] National Fuondation for Infectious Diseases. Why vaccinations are vital for older adults[EB/OL]. (2021-09-24)[2025-01-26]. https://www.nfid.org/why-vaccinations-are-vital-for-older-adults/.
[18] 中国健康促进与教育协会. 成人预防接种服务专家共识(2023年版)[J]. 中华预防医学杂志, 2024, 58(3):275-284.
[19] British Society for Immunology. A guide to vaccinations for adults over 65. [EB/OL]. (2022-11-01)[2025-01-26]. https://www. immunology. org/public-information/vaccine-resources/vaccines-adults-over-65/guide-vaccinations-adults-over-65.

收稿日期：2025-01-26 **修回日期：**2025-03-25

文字编辑：王克

《慢性病学杂志》版权声明

（1）作者所投稿件无“抄袭”“剽窃”“一稿两投或多投”等学术不端行为，对于署名无异议，不涉及保密与知识产权的侵权等问题，文责自负。对于因上述问题引起的一切法律纠纷，完全由全体署名作者负责，无需编辑部承担连带责任。

（2）来稿刊用后，该稿包括印刷出版和电子出版在内的出版权、复制权、发行权、汇编权、翻译权及信息网络传播权已经转让给《慢性病学杂志》编辑部。除以纸质载体形式出版外，本刊有权以光盘、网络期刊等其他方式刊登文稿。本刊已被《中国学术期刊影响因子年报统计源期刊》、中国知网《中国学术期刊》网络出版总库、美国《乌利希期刊指南（网络版）》（Ulrichsweb）收录。